EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 67612
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 18-07-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA ELENA VINAS LUEIZA			RUN	: 8.796.695-K
F.Nac	: 14-07-2023	Edad	: 0 AÑO	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-07-15	Fecha Egreso	: 18-07-2023	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J96.0-INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

EPICRISIS DE EGRESO

EPOC GOLD D, REAGUDIZACION RESUELTA, TABACO + BIOMASA (AUN EXPUESTA) / PROBABLE CAUSA FALTA ADHERENCIA A TTO
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA REAGUDIZACION RESUELTA
USUARIA DE O2 DOMICILIARIO (IRREGULAR , SU HERMANO SE LO PRESTA)
HIPERTENSION ARTERIAL
OBESIDAD
PROLAPTO GENITAL

FARMACOS
SALBUTAMOL SOS.
IPRATROPIO 2 PUFF CADA 4H
LOSARTAN 50MG AL DIA
HIDROCLOROTIAZIDA 12.5MG AL DIA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. R10.3-DOLOR LOCALIZADO EN OTRAS PARTES INFERIORES DEL ABDOMEN (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

INGRESA POR EXACERBACION DE SU ENFERMEDAD DE BASE CON DISNEA. REFIERE ADMEAS DOLOR ABDOMINAL.
SE SOLICITAN EXAMENES LABORATORIO, IMAGENES Y CULTIVOS.

TAC
CARDIOMEGALIA , DERRAME PERICARDICO Y PLEURAL LAMINAR

CULTIVOS
CSB NEGATIVO / PANEL VIRAL NEGATIVO.

GSA

pH 7.46 pco2 53 pO2 42 hco3 37

PARAMETROS INFLAMATORIOS BAJOS. PCR SIN REACTIVO.

SE INICIA MANEJO CON ANTIBIOTICOS , CORTICOIDES , BRONCODILATADORES Y KINESIOTERAPIA. EXCELENTE RESPUESTA.
AL CUARTO DIA CON NECESIDADES BASALES DE OXIGENO. PH NORMAL.
SE DEJÓ LA INDICACION DE VNI NOCTURNO POR BRONCOPULMONAR PERO PACIENTE LA RECHAZA ESTANDO COMPLETAMENTE EN SUS FACULTADES COMO PACIENTE.

AL DIA 18.7.2023 EN CONDICIONES DE CONTINUAR MANEJO POR HODOM HASTA EVALUACION POR DR PINOCHET EN 3 SEMANAS EN POLICLINICO DE BRONCOPULMONAR PARA TRAMITE DE OXIGENO DOMICILIARIO DEFINITIVO.

GSA AL ALTA
PH 7.42 / PCO2 55 / PO2 77 / HCO3 35.9

EVALUADO POR GINECOLOGIA PROLAPSO , CONTROL EN POLICLINICO.

PLAN DE MANEJO:

MANTENER TTO CRONICO.
SUSPENDER HIDROCLOROTIAZIDA
CONTROL POLI BRONCOPULMONAR EN 3 SEMANAS PARA O2 DOMICILIARIO DEFINITIVO

INDICACIONES AL ALTA

1. INDICACIONES AL ALTA.
2. -REGIMEN LIVIANO HIPOSODICO.
3. -REPOSO RELATIVO.
4. -AMOXICILINA CLAVULANICO 1 CADA 12 HORAS POR 3 DIAS
5. -AZITROMICINA 500MG 1 AL DIA X 3 DIAS
6. -PREDNISONA 40MG AL DIA POR 3 DIAS
7. -SALMETEROL 2 PUFF CADA 12 HORAS PERMANENTE
8. -IPRATROPIO 4 PUFF CADA 6 HORAS PERMANENTE
9. -SALBUTAMOL 2 PUFF SOS.
10. -LOSARTAN 50MG CADA 12 HORAS PERMANENTE
11. -FUROSEMIDA 1/2 EN LA MAÑANA.
12. -SUSPENDER HIDROCLOROTIAZIDA
13. -OXIGENO PARA SATURAR 88-90.
14. -KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA
15. -CONTROL EN 3 SEMANAS EN POLICLINICO BRONCOPULMONAR DR PINOCHET PARA TRAMITE O2 DEFINITIVO.

Control en: 21 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-N

JEFE SERVICIO